

19 - 02-ANATOMIE DE LA LOGE PAROTIDIENNE - Pr. ROCHDI

Toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui l'anatomie de la loge parotidienne. La loge parotidienne est une région de transition entre l'œil et le cou. C'est une région qui doit son nom à la présence de la glande parotide, qui est une glande salivaire principale, et elle constitue aussi une zone de passage de certains éléments nerveux et vasculaires très importants, et plus précisément le nerf facial qui a une importance capitale et qui rend très difficile la chirurgie au niveau de cette région.

La fréquence des tumeurs au niveau de cette glande parotide fait que le traficien ORL est fréquemment confronté à cette chirurgie, à cette région, et à la dissection du nerf facial. Donc la connaissance de l'anatomie à ce niveau là est très importante pour éviter les paralysies faciales. Alors quelles sont les limites de la loge parotidienne ? C'est un quadrilatère qui est situé à la partie supérieure et latérale du cou.

C'est une dépression lorsqu'on la regarde de l'extérieur. C'est une dépression cutanée qui est située entre la branche montante de la mandibule en avant. En arrière c'est la mastoïde avec le quart supérieur du muscle sternoclédo-mastoïdien.

En haut le conduit auditif externe et la partie postérieure de l'os zygomatique. Là c'est la limite supérieure. En bas c'est une ligne horizontale qui passe par l'angle mandibulaire.

Et en profondeur c'est l'apophyse sur le vide avec les espaces qu'on verra par la suite. L'espace latéraux paralgien. Alors la loge parotidienne, dans le plan 3D, a une forme prismatique triangle.

On lui décrit une paroi externe, une paroi antérieure et une paroi postéromédiale. Avec trois bords, un bord antérieur, un bord interne et un bord postérieur. Et deux extrémités supérieures et inférieures.

Et en même temps la glande présente des prolongements. C'est à dire que la glande parotide au sein de la loge parotidienne va présenter des prolongements qui vont dépasser la loge parotidienne. Par exemple un prolongement antérieur, un prolongement interne, un prolongement postérieur et d'autres prolongements supérieurs et inférieurs.

On les verra par la suite. Alors quelles sont les parois de la loge parotidienne ? D'abord il y a une paroi externe qui est constituée par l'aponébrose cervicale superficielle. Recouverte par le système musculo-aponévrotique superficiel qu'on appelle le SMAS.

Recouverte aussi par le tissu subversif titané et par la peau. Là c'est la paroi externe. C'est la zone à travers laquelle on peut palper la glande parotide et explorer la région parotidienne uniquement.

Donc la partie externe et superficielle de la loge parotidienne reste accessible à la palpation.

C'est un clinique où toucher au doigt nous permet d'explorer la loge ici pour rechercher des nodules, des tumeurs, des douleurs, d'inflammations locales, etc. Là c'est la paroi externe qui est tendue entre le masséter en avant et le sternocleux de mastibule en arrière.

La paroi antérieure est ostéomusculaire. C'est à dire qu'elle est constituée par deux deux rondes dents. Le masséter qui est recouvert par son appendymose.

Le muscle masséter. La branche montante de la mandibule. Le nerf sphéno-maxillaire.

En parlant pas le nerf mais le ligament. Le ligament sphéno-maxillaire. Donc on a le muscle masséter, la branche montante de la mandibule.

Le ligament sphéno-maxillaire. Et le muscle péréglédien interne. Le muscle péréglédien interne et le muscle masséter sont des muscles masticateurs.

Ces quatre éléments forment la paroi antérieure. La paroi antérieure de la loge paroxydienne. Cette partie là, le muscle péréglédien, c'est partie de notre région.

Ce qu'on appelle la force péréglomaxillaire. Le muscle péréglédien appartient exactement à la loge péréglomaxillaire. La paropocéromédiale est dite en deux parties.

Un segment externe et un segment interne. Le segment externe est formé par le muscle sternoclédome massélien, en dehors. Et le muscle digastrique en dedans, c'est-à-dire le ventre postérieur du muscle digastrique.

Ces deux muscles s'insèrent sur l'acrophyse du mastéride. Et forment le segment externe de cette paroi postérieure. Le segment interne est formé par ce qu'on appelle le rideau stylien.

C'est un ensemble de ligaments et de muscles qui s'insèrent sur l'acrophyse stylienne. Et qui limite la loge paroxydienne en arrière. Et on a deux dehors en dedans.

Le muscle stylo-iridien, le ligament stylo-iridien et le ligament stylo-mandibulaire. C'est ce qu'on appelle le rideau stylien qui permet de séparer la loge paroxydienne de l'espace rétro-stylien en arrière. Derrière ce rideau, on a l'espace rétro-stylien.

Et en avant, on a la loge paroxydienne avec l'espace rétro-stylien. Comme on a dit, la loge paroxydienne présente un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interne. Le bord antérieur présente un défilé situé au niveau d'un défilé entre la paroi latérale, le prolongement glandulaire et où apparaît le canal paroxydien.

C'est-à-dire le canal de sténon, le canal excréteur de la glande paroxyde. Ce bord antérieur de la loge est situé entre le masséter en dehors et la paroi externe de la loge en dedans. Le bord postérieur est situé sur la face externe du processus mastoïdien et aussi sur les insertions antérieures du muscle sternodomastoidien.

Le bord postérieur de la loge est situé à ce niveau-là, sur le muscle sternodomastoidien ainsi que sur la partie externe. C'est le bord postérieur de la loge paroxydienne. Le bord médial, qui est un élément très important de cette loge paroxydienne, est le musculo aponeurotique.

C'est un espace entre les ligaments scilomondébulaires et scénomondébulaires. Il peut être le siège d'un prolongement paroxydien vers l'espace latéropharyngien. Le bord médial, à ce niveau-là, c'est le bord interne de la loge, situé entre les ligaments scilomondébulaires et les ligaments scénomondébulaires.

Ce bord est fermé par une aponeurose qui est inconstante. De ce fait, la glande paroxyde peut présenter à ce niveau-là des prolongements. C'est-à-dire que la glande paroxyde sans lobe profonde peut présenter un prolongement qui peut passer entre ses deux ligaments et siéger au niveau de l'espace latéropharyngien.

Parfois, on a des tumeurs des lobes profonds, que ce soit bénis ou amasines, qui peuvent se prolonger à travers ce bord de la loge, entre ses deux ligaments, et aller donner des tumeurs paroxydiennes, mais qui sont de sièges latéraux parhyngiens. Là, c'est un élément qui est très important. Ces tumeurs sont inaccessibles à l'examen clinique.

C'est-à-dire que ces tumeurs, qui sont aux dépendances du prolongement latéropharyngien de la glande paroxyde, sont inaccessibles à l'examen clinique. On peut les explorer en examinant à travers l'oropharynx, où on va voir la tumeur qui va refouler la région amygdalienne en avant et en bas. Et même, on peut faire un palpé oropharyngé, pour avoir une idée de la texture de la tumeur, qu'elle est dure, qu'elle a sa consistance, qu'elle est douloureuse, etc.

Alors, l'extrémité supérieure de la loge paroxydienne est à la forme renversée. On voit ici. Ce V renversé est formé par deux éléments.

Le premier, c'est le conduit auditif externe, avec sa face antéro-intérieur. Et là, on parle du conduit auditif externe où se écartent les lignes. Donc, le conduit auditif externe osseux écarte les lignes au niveau de sa face antéro-intérieur.

Ainsi que la face postérieure de l'articulation temporomandibulaire. Ces deux structures forment l'extrémité supérieure de la loge et ferment vers le haut la loge paroxydienne. De ce fait, on a une limite osseux-ostéo-cartilagineuse à ce niveau-là.

L'extrémité siège au niveau de la partie inférieure du rhéobosphère. Elle est constituée par ce qu'on appelle la bandelette mandibulaire. C'est un épaississement aponeurotique qui ferme la loge paroxydienne en bas.

Donc, ce qu'on appelle la bandelette mandibulaire ou bien la bandelette interparoxydomaxillaire qui sépare la loge paroxydienne de la région submandibulaire en avant et de la région paroxydienne en arrière. Alors, quels sont les rapports de la loge paroxydienne ? D'abord en

avant, avec la région massétherine en dehors, avec principalement le masséter. Et en dedans, elle est en rapport avec la région périgomaxillaire.

Comme on l'a dit au début, la région périgomaxillaire est formée par des éléments musculaires. Les muscles périgoudiens, médias et latéraux, avec l'os maxillaire, sa grosse tubérosité, et la popule périuguide. C'est parmi les espaces profonds de la face et qui constitue le principal rapport antérieur de la loge paroxydienne.

En dehors, la région paroxydienne, comme on l'a dit, est accessible à la palpation. Elle est recouverte par une peau qui est fine, pendue entre la mandibule et la mastoïde. Et elle reprend toujours vers l'extérieur, au pavillon de l'oreille.

C'est-à-dire à sa partie intérieure, exactement le lobule de l'oreille. Et de ce fait là, lorsqu'on a par exemple des tumeurs qui siègent au niveau de l'angle superficiel de la langue paroxyde, ça entraîne un soulèvement du lobule de l'oreille. Ça nous permet de rattacher toute une infection qui siège à ce niveau-là et qui soulève le lobule de l'oreille, étant en rapport avec une lésion de la glande parotide.

Alors, en arrière, la glande parotide, comme on l'a dit au début, répond aux muscles extérieurs de la mastoïde et aux muscles digastriques. Et en arrière, à travers le rhinocylien, elle répond à l'espace rétro-cylien. L'espace rétro-cylien est un espace profond et qui livre passage à des éléments vasculonerveux très importants.

Puisqu'à ce niveau-là, on retrouve l'artère carotide interne en dedans, la veine jugulaire interne en dehors, et avec les nerfs crâniens, les nerfs mixtes, c'est-à-dire le neuvième, douzième, onzième, douzième nerf crânien, et avec un bref passage du nerf facial aussi à ce niveau-là. Là, il faut retenir ce rapport très important qui est l'espace rétro-cylien et qui est séparé de la région paro-cylienne en avant par le rhino-cylien. Donc on a l'espace rétro-cylien, le rhino-cylien, la région paro-cylienne, et à ce niveau-là, l'espace pré-cylien avec l'espace paro-paradupe.

Là, c'est un schéma qui nous montre ici le rhino-cylien, l'ensemble ligamenton musculaire qui s'insère sur la popule ciliide. Et là, c'est une fenêtre qui a été ouverte qui montre très bien ici la carotide interne avec la veine jugulaire interne. Et on voit à ce niveau-là le passage du nerf facial de l'espace pré-cylien vers la loge paro-cylienne.

Et ici, on voit le nerf glosso-paradupe au niveau de la partie interne de l'espace rétro-cylien. Alors, en dedans, les rapports internes de la loge paro-cylienne se font avec l'espace pré-cylien qui est considéré par certains auteurs comme l'espace paro-paradupe. On peut dire espace paro-paradupe ou espace latéro-paradupe.

Et comme on l'a dit tout à l'heure, la loge paro-cylienne peut présenter un prolongement qui va se faire à partir du haut profond de la paro-cylienne vers l'espace paro-paradupe. Et il peut même entraîner un refoulement de la glande paro-cyl. On voit très bien ici l'oro-pharynx avec la région

amygdalienne.

Donc on peut avoir des lésions tumorales du haut profond de la paro-cyl qui peuvent s'étendre dans l'espace paro-pharynx, refouler la région amygdalienne et parfois être source d'obstruction des voies aériennes supérieures. Cette zone-là du haut profond dans certains cas est accessible à l'examen clinique à travers l'oro-pharynx où on voit éventuellement le refoulement de la région amygdalienne et on peut même palper cette zone-là à travers l'oro-pharynx. Donc là c'est un schéma qui montre très bien ici, là c'est une vue d'en arrière où on voit très bien l'espace rétro-stylien avec la mastoïde ici en dehors, l'insertion du muscle perno-crêdo-mastoïdien et du muscle biodeptrique.

Ici c'est la prophésie styloïde avec le rideau stylien, le muscle stylo-oligien, le ligament stylo-oligien, le ligament stylo-mandibulaire. Et on a, dans l'espace rétro-stylien, l'ADN jugulaire interne en dehors et l'artère carotide interne en dedans. Là vous voyez les structures nobles qui passent à travers cet espace.

La connaissance de la position anatomique de ces structures nous permet dans certains cas de nous guider dans le diagnostic des lésions tumorales qui peuvent siéger à ce niveau-là. Par exemple, une tumeur qui est née au niveau de cette zone et qui refoule l'artère carotide interne en avant, on va la rattacher à l'espace rétro-stylien. Au contraire, une masse qui siège en avant de la prophésie styloïde et qui refoule l'artère carotide interne et l'ADN jugulaire en arrière, on va la rattacher à l'espace pré-stylien, ou bien à la région parotidien.

Parotidien, ils vont se faire avec la base du crâne et essentiellement avec le corumbioidite externe qui siège au niveau de l'os temporale. Donc on a le corumbioidite externe en avant et en arrière on aura le trou stylo-mastroïdien à travers lequel le nerf facial quitte l'os temporale pour passer au niveau de l'espace pré-stylien et puis directement vers la région parotidien. En bas, la bandette maxillaire sépare la région parotidienne de la région sous-maxillaire.

En dehors, le triangle pré-stylo-hémidien, en bas, livre passage à l'artère carotide externe. C'est-à-dire qu'en bas, la région parotidienne est en rapport à travers la bandelette maxillaire avec la région sous-mondilulaire en avant et en dehors et en arrière est en rapport avec la région carotidienne. On voit très bien ici la région carotidienne avec la carotide commune, la bifurcation, la carotide externe qui passe et traverse cette paroi intérieure dans le triangle pré-stylo-hémidien, c'est-à-dire entre le muscle stylo-hémidien et le ligament stylo-hémidien.

L'artère carotide qui pénètre dans la loge et qui traverse, qui va traverser la grande parotide. Mais derrière le rideau stylien, l'artère carotide interne continue son chemin vers la loge du crâne. Donc là, ce sont deux coupes.

Ça, c'est une coupe horizontale, dans le plan horizontal, un scanner de la face. Et ça, c'est une coupe horizontale de l'IRM, c'est-à-dire de l'image faite par résonance magnétique de la face. Là, on voit très bien la branche montante de la mandibule, le muscle massétoire, le péridivien

interne.

Et on voit très bien aussi la glande avec la région carotidienne. On voit les rapports antérieurs avec la région massétoire. La région pérogo-maxillaire.

Donc ça, on a ici la région parotidienne. La région pérogo, c'est-à-dire la face pérogoïde. Maxillaire, l'os maxillaire.

C'est ce qu'on appelle la région pérogo-maxillaire. Et on voit très bien ici les rapports avec le rideau stilien, l'espace rétro-stilien. Vous avez ici la profile stilienne.

Avec le rideau stilien. Derrière le rideau stilien, on a l'arc carotidien interne. La région interne avec l'arc carotidien qui nous accompagne à ce niveau-là.

Et là, on a l'espace pré-stilien avec les espaces latéraux paralléliens. Vous voyez le rapport avec le pharynx ici. Donc on a l'espace pré-stilien.

Ça, c'est la région parotidienne. Et en arrière, on a l'amastoïde. La même chose ici.

On voit très bien ici la mandibule. Le muscle massétoire. Le muscle pérogoïdien interne.

Et on voit très bien ici la glande parotidique avec la région parotidienne. Ce forme d'un prisme à trois faces. Face externe, face posthéromédiale et face antérieure.

Et là, l'espace rétro-stilien. Avec les éléments qui nous accompagnent. Et à ce niveau-là, l'espace pré-stilien.

Alors là, c'est un schéma qui nous montre la disposition de la région parotidienne par rapport aux autres espaces au fond de la face. Comme on vient de le dire, ça c'est l'espace parotidien avec la glande parotide, la paroi externe, posthéromédiale et antérieure. En avant, c'est l'espace masticateur avec le muscle massétoire en dehors et la région pérogo-maxillaire en dedans.

En arrière, on a l'espace rétro-stilien. C'est l'espace rétro-stilien ici. On voit ici le lobe, la région profonde de la région parotidienne.

Et là, c'est l'espace pré-stilien, c'est-à-dire l'espace paraparangé. Là, on a le pharynx. Là, c'est l'espace rétro-parangé.

Donc on a le pharynx, l'espace rétro-parangé, l'espace paraparangé ou latéroparangé ou l'espace pré-stilien. Et si on continue en dehors, on a la loge parotidienne qui est en rapport avec l'espace masticateur en avant et en arrière, l'espace rétro-stilien. C'est un schéma juste pour situer, pour savoir où se situe la loge parotidienne par rapport aux autres espaces au fond de la face.

Alors maintenant qu'on a vu les limites, les parois et les rapports de la loge parotidienne, on va

s'intéresser au contenu. Comme son nom l'indique, la loge parotidienne contient la glande parotide qui est une glande salivaire principale, une glande exocrine, responsable de la sécrétion de la salive, ferreuse. Elle a une forme prismatique à trois faces et les pousses quotidiennes.

Son aspect microscopique est les jambes rosées, fer, l'obulé, qui est entouré par une capsule fibreuse et présente deux lobes, superficiels et profonds, qui sont séparés par le passage du nerf facial. En fait, il n'y a pas de délimitation exacte entre le lobe profond et le lobe superficiel. C'est juste que tout ce qui est en-dehors du nerf facial, c'est le lobe profond, et tout ce qui est en-dehors du nerf facial, c'est le lobe superficiel.

Mais entre les deux, il n'y a pas vraiment de limite anatomique distincte. La glande présente un canal excréteur, ce qu'on appelle le canal de Steynand, qui va naître au niveau de son bord antérieur. Ce canal de Steynand, c'est-à-dire ce canal parotidien, va cheminer d'abord dans une direction qui va être horizontale sur la face externe du masséter, au-dessous de l'arcade gommatique, à peu près à un centimètre.

Après, une fois qu'il dépasse le bord antérieur du muscle masséter, il va faire un virage à peu près à 90 degrés pour aller passer en avant de la moule graisseuse de Bichat. Après, il va perforer le muscle diximateur à ce niveau-là. Là, on voit le muscle diximateur ici.

Il va le perforer pour aller s'aboucher au niveau de la muqueuse du cas. L'orifice, l'ostium du canal de Steynand, en général, il est en regard de la première, deuxième monnaie supérieure. Là, on peut dire qu'il a un trajet en baïonnette, d'abord derrière en avant, puis de dehors en dedans, après derrière en avant pour s'aboucher ici au niveau de la muqueuse.

Le canal de Steynand est un canal qui est palpable. On peut le palper à un centimètre au-dessous de l'arcade, de l'ostie gommatique, sur la face externe du muscle masséter. De ce fait, il est très superficiel et il est exposé aux traumatismes et aux plaies lors des plaies de la face.

Lorsqu'on a, par exemple, une plaie, en général, dans les agressions par arme blanche, on peut avoir des sections du canal de Steynand. C'est pour ça que, toujours devant tout plaie de la face qui passe entre l'arête de l'oreille et la commissure labiale, il faut absolument, lorsque cette plaie dépasse le plan musculaire, il faut absolument vérifier s'il n'y a pas d'atteinte du canal par aussi bien. La vérification peut se faire à travers la plaie ou bien par cathéterie du canal à travers son orifice du cœur.

Là, c'est juste pour rappeler les prolongements de la glande par interne vers les espaces parapharangés, antérieure sur la face externe du muscle masséter, on le voit ici, inférieure vers la région jugulocarotidienne, postérieure sur la face externe du muscle sternocleidomastoidien et la face externe de la mastoïde, supérieure en avant des tragus, ce qu'on appelle un prolongement tragale, comme on peut avoir, de toute façon, aussi un prolongement vers la région submandibulaire, en cas de déchirure au niveau de la bandelette parotidienne. Parfois,

on peut avoir une glande parotide qui se continue avec la glande submandibulaire. Deuxième construction, et qui est le plus important au niveau de la loge parotidienne, c'est le nerf facial.

C'est un pèrè crânien. Il présente, au niveau de la loge, deux segments. Premier segment, c'est-à-dire, après son passage de l'espace rétro-stilien dans la glande parotide, bien sûr, entre le muscle bigastrique et le muscle stylo-ihilien, et de ce fait, le muscle bigastrique, c'est le repère que les chirurgiens utilisent pour retrouver le nerf facial.

La recherche du nerf facial, parmi les premiers temps qu'il faut entreprendre lors de la chirurgie de la glande parotide, c'est la recherche du nerf facial. Parmi les repères qu'on a, c'est le ventre extérieur du muscle bigastrique. Le nerf, il passe dans la loge parotidienne, en-dedans du ventre extérieur du muscle bigastrique, et en-dehors du muscle stylo-ihilien.

Le trajet rétro-parotidien est court. Après le nerf, il va pénétrer dans la glande parotide, dans une direction d'avant en arrière, d'arrière en avant, et de dehors en dehors. C'est-à-dire que le nerf, au fur et à mesure qu'il traverse la glande parotide, le nerf est de plus en plus superficiel.

Parmi les éléments qui vont siéger à l'intérieur de la glande parotide, le nerf facial est le plus superficiel. On voit très bien ici le nerf, le plan veineux et le plan artériel. Le plan du nerf facial en dehors, le plan veineux entre les deux, et le plan artériel, qui est le plan le plus profond.

Le nerf facial dans la glande parotide va se diviser en deux branches. A ce niveau-là, le nerf facial se termine en deux branches. Une branche temporopartiale et une branche cervicopartiale.

La branche temporopartiale, c'est pour l'innervation de l'étage supérieur au moyen de la face. La branche cervicopartiale, c'est pour l'innervation de l'étage inférieur de la face, la lèvre inférieure, le montant et les muscles pousiers du cou. Après les branches du nerf facial, là, ils vont quitter la glande au niveau de son bord antérieur, après être divisées en branches de deuxième, troisième degré, etc.

Donc le nerf facial, c'est le nerf qui donne toute l'importance à cette zone, qui est la loge parotidienne, puisque c'est un nerf qui a un rôle très important dans la mimique et qu'il faudra préserver au cours de toute chirurgie de la loge parotidienne. Le troisième élément, c'est le nerf auriculotemporal. Alors, c'est quoi le nerf auriculotemporal ? C'est une branche du nerf mandibulaire, c'est-à-dire le nerf trigemont.

Donc on a le nerf trigemont qui va donner trois branches. La troisième branche, c'est le nerf mandibulaire. Et le nerf mandibulaire, au niveau de la loge périgomaxillaire, il va donner le nerf auriculotemporal.

Le nerf auriculotemporal qui va passer de la loge périgomaxillaire vers la loge parotidienne, à la face interne de la mandibule. Donc ici, on a la face, ça c'est le nerf auriculotemporal. Ça c'est une vue interne, c'est-à-dire qu'on va regarder la branche montant de la mandibule d'en-dedans.

Et ici, on regarde la branche montant de la mandibule à partir de l'extérieur. Donc en-dedans, on a ici la loge périgomaxillaire, le nerf mandibulaire, qui va donner le nerf auriculotemporal qui va passer en-dedans du col du conduit de mandibulaire, de la loge périgomaxillaire pour atteindre la loge parotidienne. Vous voyez ici, il passe et qu'il est accompagné par la veine maxillaire interne et l'artère maxillaire interne.

Puis il va passer de la loge périgomaxillaire vers la loge parotidienne. Après, il va suivre le pénicule temporal superficiel, c'est-à-dire l'artère et la veine temporale superficielles. Donc le nerf temporal, au cours de son trajet, il va faire des anastomoses avec les branches du nerf facial.

En même temps, il va donner des filets sécrétoires pour la glande parotide. Et par la suite, au cours de son trajet, il va innover l'émersion liquide de la région temporale. Alors, on a vu le contenu de la glande parotidienne, de la glande parotide, le nerf facial et le nerf auriculotemporal.

Maintenant, on verra les structures vasculaires. Il y a d'abord l'artère carotide interne. Comme son nom l'indique, c'est une branche terminale de l'artère carotide commune.

Il l'est au niveau de la région carotidienne. Après, il va passer entre le muscle styloïdien et le gammon styloïdien. C'est le triangle pré-styloïdien pour pénétrer dans la branche parotidienne.

Après, il va pénétrer dans la glande et elle va se diviser en deux branches terminales. L'artère temporale superficielle qui continue dans la direction verticale pour aller vers la région temporale en passant en avant du cône du liquide externe, accompagné par le nerf auriculotemporal et par la veine temporale superficielle. En avant, l'artère maxillaire interne.

Il va gagner la force intratemporale, c'est-à-dire d'abord la région périgomaxillaire. Après, il passera au niveau de la force nasale pour vasculariser la muqueuse de force mentale. Alors, au cours de son passage dans la région périgomaxillaire, il va passer dans ce qu'on appelle le tunnel stylo-mandibulaire accompagné par la veine maxillaire interne et par le nerf auriculotemporal.

Deuxième élément vasculaire, c'est le confluent veineux à l'intérieur de la branche parotide. La veine temporale superficielle, la veine maxillaire interne, vont s'investir dans le musée pour former un confluent veineux qui va nous donner deux structures. Et ces deux structures vont quitter la branche parotidienne ou sa paroi inférieure.

En premier, il y a la veine musculaire externe qui va se diriger en dehors en passant sur la face externe du muscle parotidien. Deuxième structure veineuse, c'est la veine communicante intraparotidienne. Qui va réaliser une anastomose avec la veine axiale.

Dernier élément concernant le contenu parotidien, c'est les ganglions parotidiennes. Il faut savoir qu'il y a des éléments lymphatiques à l'intérieur de la branche parotidienne. Il y a des ganglions lymphatiques qui sont divisés en deux groupes.

Groupes profonds et groupes superficiels. Le groupe profond intraglandulaire qui va drainer l'os mammal, les os du palais et l'oreille mouillée. Et un groupe superficiel qui va drainer l'os extraglandulaire, qui va drainer la région temporale et faciale.

Les deux groupes vont se drainer vers la chaîne jugulaire interne. L'importance de connaître qu'il y a des ganglions parotidiens et des régions qui le drainent, c'est du fait qu'on peut avoir des métastases ganglionnaires intraparotidiennes de certains cancers O.R. Par exemple, les tumeurs de la région nasale, les tumeurs de la région temporale, de la région frontale, de la région orbitale, peuvent donner des métastases ganglionnaires au niveau de la région parotidienne. Il faut prendre en considération cette notion et poser une indication d'une parotidectomie dans la prise en charge de ces tumeurs.